

升胃冲剂的制备及临床观察

张升良 (陕西省岐山县中医医院药剂科 722400)

根据我院近十年来枳术参朴散治疗胃下垂的经验,将原方进行适当调整后,制成升胃冲剂,用于胃下垂的治疗,收到了满意效果,现报道如下。

1 处方组成

白术 300g、人参 100g、茯苓 200g、枳实 200g、陈皮 200g、半夏曲 200g、川厚朴 200g、莱菔子 200g、玉片 200g、砂仁 150g、黄连 150g、干姜 150g、甘草 100g、麦芽 250g。

2 制备方法

2.1 取白术、半夏曲、麦芽粉碎,过 120 目筛,得细粉,粗末备用;2.2 取砂仁、陈皮、枳实、干姜、厚朴,用 70%乙醇浸渍,收集浸渍液适量,药渣备用;2.3 取人参、茯苓、莱菔子、玉片、黄连、甘草与上粗末及药渣共煎 3 次,每次 1h;2.4 浸膏加部分细粉,80℃以下干燥,粉碎,过 120 目筛;2.5 将浸膏粉与细粉加适量糖粉,用浸渍液湿润,过 16 目筛制粒,60℃以下干燥,分装成 600 袋,即可。

3 用法

Tid, 1 袋/次。30d 为一个疗程。

4 临床观察

用升胃冲剂治疗胃下垂 100 例,年龄最大者 65 周岁,最小者 22 周岁,病程半年到 10 余年不等,下垂程度轻重均见。其中治愈(自觉症状消失,X 线钡餐造影胃位恢复正常,半年以上未见复发者)75 例,有效(自觉症状消失或减轻,X 线钡餐造影胃位较服药前有所升高)22 例,无效(服药二疗程,诸症仍未减轻,X 线钡餐造影胃位无明显改变者)3 例,总有效率达 97%,一般治愈时间为 2 疗程。

5 讨论

5.1 组方结合“胃以通为补”的原则,采用通补兼施的手段,扩大了中医在治疗胃下垂方面“补气举陷”、“补养胃阴”的 2 大传统方法。5.2 方中人参、白术、茯苓、甘草补中益气,旨在固本;砂仁、厚朴、陈皮、玉片、半夏曲、麦芽理气消导,助胃气通顺;干姜、黄连辛苦而开胃健胃寒热而阴阳并调,以使中焦气机升降正常,达到标本兼顾,提高治疗效果。5.3 由散剂制成冲剂,不但口感舒适,减小了对胃的刺激,且根据药物性质分别采取了不同制备方法,保证了有效成分的充分提取。

氟喹诺酮类的药物相互作用

邓万俊 (湖南省衡阳市中国人民解放军 415 医院 421002)

氟喹诺酮类是近年迅速发展起来的一类合成抗菌药物,其抗菌谱广、抗菌活性强、组织体内浓度高、吸收完全、半衰期长、不良反应大多轻微,目前应用甚广。由于临床上与氟喹诺酮类联合用药的机会很多,因此有关的药物相互作用颇受关注。

1 甲基黄嘌呤类

1.1 茶硷:由于某些氟喹诺酮类对呼吸道感染病原菌抗菌活性强,能很好透入肺组织,呼吸道分泌液中浓度高,故常与支气管松弛剂茶硷合用治疗呼吸道感染。但最近研究证实,氟啶酸、环丙氟哌酸、甲氟哌酸、氟哌酸通过抑制肝脏细胞色素 P₄₅₀ 系统的同功酶,抑制茶硷的 N 位脱甲基化过程,从而使茶硷的清除率下降^[1]。

这一相互作用的程度与氟喹诺酮类的剂量呈正相关;随着年龄增长,这一作用越明显。据报道,氟啉酸及环丙氟哌酸可使血浆茶砵浓度升高1~2倍,出现恶心、呕吐、心动过速、头痛、失眠、幻觉、震颤甚至惊厥等不良反应。故二者合用应减少茶砵用量,并监测血浆茶砵浓度。

较新的氟喹诺酮类如氟嗟酸、多氟哌酸、洛美沙星及氟啉酸、Temafloracin、Sparfloracin 等对茶砵的清除无明显影响。

1.2 咖啡因:氟啉酸减少咖啡因之清除,使消除半衰期延长26%,最大达峰浓度时间延长41%,分布容积减少20%,总清除率下降78%^[2],从而使胃肠道及中枢神经系统不良反应发生率增高。而氟哌酸及环丙氟哌酸与咖啡因的相互作用不具临床意义。

2 H₂受体拮抗剂

甲氧咪胍能抑制肝细胞色素P₄₅₀系统参与的I相代谢反应,因此凡在肝脏代谢的氟喹诺酮类与之合用,均可使氟喹诺酮类的肾外清除率下降。如甲氧咪胍与甲氧咪胍合用,前者的肾外清除率下降24%,Temafloracin与甲氧咪胍合用,前者的清除半衰期由7h延至9h。

此外已经证实,大部份氟喹诺酮类的肾清除不仅与肾小球滤过率有关,也与肾小管的分泌功能有关。甲氧咪胍能减少某些氟喹诺酮类的肾小管分泌,从而使后者的肾清除减低。对健康人的研究表明,甲氧咪胍可使氟啉酸、氟嗟酸及Temafloracin的肾清除减少5~20%,消除半衰期延长30%^[2]。然而至今未能证实环丙氟哌酸、多氟哌酸与甲氧咪胍或雷尼替丁的重要的相互作用。

3 多价金属阳离子

动物试验及临床均证实,氟喹诺酮类与铝、镁、钙、铁、锌等多价金属阳离子可发生相互作用。其机理是上述金属阳离子能与氟喹诺酮类的4-酮氧基3-羟基发生络合作用,从而减少氟喹诺酮类的吸收及生物利用度,致使后者抗菌治疗失败^[3]。例如,抗酸剂与环丙氟哌酸或氟嗟酸合用,可使后二者的血清浓度下降4~20倍,使时间-浓度曲线下面积(AUC)减少3~

10倍。因此,临床应避免氟喹诺酮类与含镁、钙氢氧化物的抗酸剂或硫糖铝、硫酸亚铁、含锌的多种维生素等合用,如不能避免时,在应用上述金属阳离子药物之前2h给予氟喹诺酮类,可使这一相互作用大为减轻^[4],但上述措施对硫糖铝无效。

4 非甾类抗炎药

已经证实,能抑制γ-氨基丁酸(GABA)与其受体结合的药物可增加中枢神经系统的兴奋性导致惊厥。氟喹诺酮类不但使GABA自神经末梢的释放减少,尚可竞争性抑制GABA与突触后受体的结合。这一作用与氟喹诺酮类的亲脂性及浓度有关,其亲脂性越小,竞争性抑制能力越大;浓度越高,抑制能力越强。^[5]最近证实,某些非甾类抗炎药及其代谢产物可使氟喹诺酮类的上述作用增强。

联苯丁酮酸与氟喹诺酮类合用可诱发惊厥,与布洛芬合用可诱发痉挛发作^[2]。其他氟喹诺酮类与非甾类抗炎药合用是否有类似作用,未见报道。为避免发生不良反应,对既往有癫痫病史、急性脑血管病患者,不应合用上述药物。一旦发生惊厥,除立即停药、确保呼吸道通畅外,应给予巴比妥类镇静剂^[6]。

5 华法令

已有数例报道,华法令与氟喹诺酮类合用可使凝血酶元时间延长,确切机制不清^[7]。因此二者合用应密切监测凝血时间,防止出血并发症。

6 丙磺舒

丙磺舒因能阻滞肾小管分泌,从而减少某些氟喹诺酮类的肾清除。据报道,丙磺舒可使环丙氟哌酸、氟啉酸、氟哌酸的肾清除率下降50%^[8],但总清除率无改变。这可能是由于肾外清除代偿性增加的结果。值得注意的是氟嗟酸与丙磺舒合用时,肾清除率及总清除率均降低,而氟哌酸与丙磺舒合用,并不使前者的清除率发生改变。

7 环胞素

器官移植时应用环胞素及氟喹诺酮类,少数病例发生可逆性肾功能不全。推测氟喹诺酮

类可抑制环孢素的代谢,从而发生上述不良相互作用^[9]。

8 丁溴东莨菪碱及驱蛔灵

二者均延缓环丙氟哌酸的吸收,影响后者的抗菌效果^[2]。

9 优降糖

氟哌酸可降低优降糖的口服生物利用度,故二者合用应监测血糖浓度^[10]。

10 利福平

动物试验表明,利福平可加速环丙氟哌酸代谢,使其血药浓度下降,导致治疗失败,但最近对人的临床观察未发现上述相互作用^[11]。

参 考 文 献

- 1 Edwards DJ, Bowles SK, Svensson CK, et al. Inhibition of drug metabolism by quinolone antibiotics. Clin Pharmacokinet, 1988, 15:194~204
- 2 刘定勇,李良宏译,氟喹诺酮类药物相互作用研究,国外医药抗生素分册,1990,11(1):57~60
- 3 Janknegt R. Drug interaction with quinolones. J Antimicrob Chemother, 1990, 26:7~29

- 4 Stein GE. Drug interaction with fluoroquinolones. Am J Med, 1991,91:81~86
- 5 Halliwell RF, Davey PG, Lambert JJ. The effects of quinolones and NSAID upon GABA-evoked currents recorded from rat dorsal root ganglion neurones. J Antimicrob Chemother, 1991,27:209~218
- 6 蒋明方,沈稚舟,吡啶酮羧酸类抗菌药物与其他药物的相互作用,国外医药抗生素分册,1991,12(1):68~69
- 7 Jolson HM, Tanner LA, Green L. et al. Adverse reaction reporting of interaction between warfarin and fluoroquinolones. Arch Intern Med, 1991,151:1003~1004
- 8 Wijndands WJA, Vree TB, Baars AM, et al. Pharmacokinetics of enoxacin and its penetration into bronchial secretions and lung tissue. J Antimicrob Chemother, 1988,21:67~77
- 9 Avent CK, Krinsky D, Kirklin JK, et al. Synergistic nephrotoxicity due to ciprofloxacin and cyclosporine. Am J Med, 1988,85:452~453
- 10 沈向忠,陆再再,氟喹诺酮类与其他药物的相互作用,国外医药抗生素分册,1990,11(2):155
- 11 管剑龙,汪复,氟喹诺酮类抗菌素与其他药物的相互作用,国外医药抗生素分册,1991,12(3):236

(1992年11月4日收稿)

酚妥拉明在非心血管疾病中的应用

孙羽非(陕西省临潼核工业 417 医院 710600)

关键词 酚妥拉明,非心血管病

酚妥拉明为 α 受体阻滞剂,主要用于治疗心血管疾病。近年来其临床用途日趋拓宽。本文就该药在非心血管疾病中的应用简述如下:

1 治疗新生儿疾病

王艳林等^[1]报告新生儿重症肺炎 11 例。在综合抢救措施无效或效果不满意时,静脉给予酚妥拉明,用药 8h 显效 7 例,有效 4 例。仅 1 例因合并严重硬肿症而死于肺出血。汤文^[2]报道 46 例新生儿胎粪吸入综合征,伴有呼吸困难,紫绀者,静滴酚妥拉明,连用 2~4d。一般用药后呼吸困难均有不同程度好转,4d 左右完全缓解。酚妥拉明除具有扩张血管作用,尚能使支气

管扩张,改善肺血管平滑肌痉挛状态,降低肺循环阻力,从而改善呼吸功能。

2 治疗婴幼儿中毒性脑病

康宏伟等^[3]报道婴幼儿肺炎 2638 例。用扩血管药的 912 例,并发中毒性脑病 4 例(0.44%);而未使用扩血管药的 1726 例,并发中毒性脑病 55 例(31.9%),两者差异显著 $P < 0.01$ 。方法为酚妥拉明和多巴胺等量联合静滴。根据病情每日用 1~3 次,除少数患儿出现烦躁外,未见其他副作用。酚妥拉明可改善微循环,解除支气管痉挛,早期应用可阻断因循环障碍和缺氧引起的中毒性脑病的发生。